Chapitre 2 – Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé · carte mentale complète

Déterminants, inégalités et mesure de l'état de santé

1. Déterminants de santé

DÉFINITIONS
- **OMS 1998** : facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence la santé
- Facteur de **risque** (proba ↑) ≠ cause certaine ; facteur de **protection**
- Constat → **diagnostic** (« parce que… ») → choix du levier

5 DISTINCTIONS
- Modifiable / non modifiable · individuel / collectif
- **Proximal** (sel) / **distal** (prix, revenu)
- **Structurel** (diplôme) / **intermédiaire** (logement sans cuisine)

ÉTUDES HISTORIQUES
- **McKeown 1976** : ↓ tuberculose avant les soins → alimentation, conditions de vie
- **Whitehall** (Marmot, dès 1967) : **gradient social** chez des fonctionnaires

ALIMENTATION : 6 FAMILLES
- Individuels · sociaux et culturels · **économiques**
- Environnement **alimentaire** · environnement **physique** · politiques
- **Désert** (accès au frais difficile) ≠ **marais** (saturé de fast-food)

2. Trois modèles

LALONDE 1974
- **4 champs** : biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins
- Limite : culpabilise l'individu

DAHLGREN ET WHITEHEAD 1991
- **5 couches** : âge-sexe-hérédité → mode de vie → réseaux → conditions de vie et de travail → conditions générales
- Comportements **enchâssés** ; couche extérieure = plus de personnes touchées

CDSS OMS 2008 (SOLAR ET IRWIN 2010)
- **Structurels** : contexte + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine)
- → **Intermédiaires** : matériels, psychosociaux, comportements, système de santé → équité

3. Inégalités sociales

DÉFINITIONS
- **ISS** : systématiques, **évitables**, **injustes**
- **Gradient** : santé ↑ à chaque échelon → universalisme proportionné
- Équité ≠ égalité ; iniquité (Whitehead 1990)

CHIFFRES
- EV : **≈ 13 ans** (H) et **8 ans** (F) d'écart, 5 % modestes / aisés (**Insee 2018**)
- Obésité 18,1 % ; **24,7 %** si difficultés (OFÉO 2024)
- **16 %** pas assez à manger (Crédoc 2022) ; littératie problématique 44 %

MÉCANISMES
- Matériels · psychosociaux · comportementaux · accès aux soins · parcours de vie
- **Rapport Black 1980** : artefact, sélection, culturel, **matérialiste** (principal)

NIVEAU DE VIE
- Revenu disponible / **UC** (1 ; 0,5 ≥ 14 ans ; 0,3 < 14 ans)
- Seuil de pauvreté = **60 % du médian** ; EPICES (11 questions)

4. Territoires et précarité

INÉGALITÉS TERRITORIALES
- Nord, nord-est, **outre-mer** (Mayotte + 89 %, Guyane + 37 %)
- QPV (critère : faible revenu) · rural isolé · loi Lurel 2013
- **Composition** (qui y vit) ≠ **contexte** (le lieu agit)

PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
- **EGalim, art. L. 266-1 CASF** : sûre, diversifiée, de qualité, suffisante ; **dignité**
- Insécurité alimentaire (FAO) : échelle **FIES** (8 questions)

EFFET MATTHIEU
- Info pour tous : cadres + 10 %, ouvriers + 2 % → écart ↑
- Ne pas stigmatiser : citer les ressources du quartier

5. Démographie

FRANCE (INSEE)
- **69,1 M** hab. (1/1/2026) ; 65 ans + **22,2 %**
- **645 000** naissances ; **ICF 1,56** (2025) ; remplacement 2,1
- Solde naturel **− 6 000** (1re fois depuis 1945)

FORMULES
- Natalité = naissances / pop. moyenne × 1 000
- Fécondité = naissances / femmes 15-49 ans × 1 000 ≠ ICF
- Dépendance = (< 20 + 65 +) / 20-64 × 100 ; **vieillissement** = 65 + / < 20 × 100

ESPÉRANCE DE VIE
- **85,9 F / 80,3 H** (2025) ; génération **fictive** ≠ âge au décès
- **EVSI** à 65 ans : **11,8 F / 10,5 H** (Drees, 2024)
- IDH : EV + durées de scolarisation + RNB/hab. (depuis 2010)

PYRAMIDE
- Triangle (jeune) · cloche · **meule** (France)
- Présenter → forme → anomalies → chiffrer → conclure (public)

6. Mortalité

TAUX
- Brut = décès / pop. × 1 000 ; spécifique ; par cause / 100 000
- **Infantile** = décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000 (≈ 4 ‰)
- **Prématurée** < 65 ans ≠ **évitable** < 75 ans

STANDARDISER
- **Directe** : taux du territoire × pop. de référence
- **Indirecte** : **RSM** = observés / attendus ; **ICM** = RSM × 100
- IC ≈ D ± 1,96 √D ; ne pas comparer 2 RSM

CAUSES 2024
- **641 046** décès ; **tumeurs 27,1 %** ; **cardio-NV 21,2 %**
- APVP : Σ (75 − âge au décès)

7. Morbidité et nutrition

MORBIDITÉ
- **Prévalence** = cas existants / pop. ; **incidence** = nouveaux / pop. **à risque**
- **Prévalence ≈ incidence × durée** ; taux d'incidence en personnes-années
- Létalité (décès / malades) ≠ mortalité ; taux d'attaque (TIAC)

ÉTAT NUTRITIONNEL
- IMC ≥ 30 obésité ; tour de taille ≥ **102 H / 88 F**
- Enfant : courbes 2018, **IOTF-25/30**, rebond précoce
- **Mesuré ≠ déclaré** (poids sous-estimé)

ÉCHANTILLON
- Marge = **1,96 √(p(1−p)/n)** ; n = 1,96² p(1−p) / e²
- p 0,5, e 5 pts → **385** ; marge / 2 = n × 4
- La marge ne corrige pas les **biais**

DÉNUTRITION 70 ANS + (HAS-FFAMCO 2021)
- 1 phénotypique (perte ≥ 5 %/1 mois, ≥ 10 %/6 mois ; **IMC < 22** ; sarcopénie) + 1 étiologique
- Sévère : IMC < 20 ; albumine ≤ 30 g/L

8. Transitions et fardeau

TRANSITIONS
- **Démographique** : 4 phases → vieillissement
- **Épidémiologique** (Omran 1971) : infectieuses → chroniques (74 % des décès)
- **Nutritionnelle** (Popkin 1993) ; **double fardeau**

FARDEAU EN FRANCE
- **49 % surpoids dont 17 % obésité** (Esteban 2015) ; enfants 17 % dont 4 %
- Diabète traité **> 3,8 M** (5,6 %, 2023)
- **41 %** des cancers évitables (CIRC 2018)

INDICATEURS SYNTHÉTIQUES
- **AVCI = AVP + AVI** ; QALY (coût par QALY)
- GBD 2017 : risques alimentaires ≈ 11 M décès ; 1er = **sodium**

9. Association et études

MESURES
- **RR = R1 / R0** ; DR = R1 − R0 ; **OR = ad / bc**
- FAE = (RR − 1) / RR ; RR 0,6 = − 40 %

PRUDENCE
- **Confusion** : lié à l'exposition ET à l'effet → stratifier, ajuster
- Biais de sélection, d'information ; causalité inverse
- **Bradford Hill 1965** : temporalité seule indispensable

ÉTUDES
- Écologique · transversale · cas-témoins (OR) · **cohorte** (RR) · essai · méta-analyse
- Grades HAS : A, B, C, AE

ENQUÊTES
- **INCA 3** (2014-15) · **Esteban** (2014-16, mesuré) · Albane
- Elfe 2011 · NutriNet-Santé 2009 · Constances 2012
- Fiolet BMJ 2018 : HR 1,12 ultra-transformés

10. Sources, leviers, méthodes

SOURCES
- **Insee** (Filosofi) · Drees · **CépiDc** (causes) · SpF (**Géodes**) · data.ameli · **ORS** (Score-santé)
- Recueil local = seule source des besoins **ressentis**

PORTRAIT EN 6 ÉTAPES
- Territoire → démographie → social → santé → déterminants et ressources
- **Comparer, dater, sourcer**, 3-5 constats (F1)

LEVIERS
- EIS ; santé dans toutes les politiques (Helsinki 2013)
- **NOURISHING** (WCRF 2013) ; grille pondérée (impact, faisabilité, équité)
- Lentille inégalités (6 questions) ; écart **absolu** (pts) ≠ **relatif**

COÛT ET FIL ROUGE
- **Loi d'Engel** ; journée conforme ≈ 3,46 € ; lentilles 0,16 €/portion
- Tilleuls : < 18 ans 32 %, pauvreté **41 %**, surpoids GS 14 vs 9 %

Pièges ✕ Comparer des **taux bruts** → standardiser ✕ Incidence sur toute la population → **population à risque** ✕ Confondre **points** et **écart relatif** ✕ Oublier le **gradient** social ✕ Comparer **mesuré** et **déclaré** ✕ EV = âge moyen au décès (faux) ✕ **Association ≠ causalité** ✕ Biais **écologique** : territoire ≠ individus ✕ « Les familles mangent mal » (comportements seuls) ✕ Dénutrition 70 ans + = **HAS-FFAMCO 2021**